



O Segundo Cérebro dos Eventos

LIVEBOOK

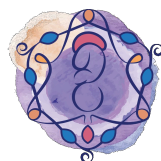
A Reforma Obstétrica no Brasil

Análise crítica e implicações para a prática profissional

Palestrante

Luciane da Silva D'Avila

Enfermeira Obstétrica · Presidente da ABENFO Nacional



Siaparto

São Paulo / SP · 2025

Sumário Executivo Estratégico

A palestra de Luciane D'Avila articula uma tese estruturante: o problema brasileiro de saúde materno-infantil não é de recursos, é de arquitetura institucional. Nenhuma política pública obstétrica brasileira moveu indicadores principais (cesarianas, mortalidade materna, equidade racial) porque nenhuma alterou a coordenação do cuidado — manteve o modelo médico-centrado e hospitalocêntrico como matriz. A proposta da Reforma Obstétrica desloca o eixo: redistribuir autoridade clínica para que enfermeiras obstétricas e obstetrizes coordenem o cuidado em risco habitual, com obstetras na retaguarda das complicações.

Para o profissional pleno, três aspectos merecem atenção imediata. Primeiro, a tese é tecnicamente sustentada: a OMS (no documento de 2024) projeta que apenas 10% de aumento na cobertura por enfermeiras obstétricas com autonomia plena evitaria 23% das mortes maternas e neonatais. Segundo, a Reforma já tem trilhos institucionais: Manifesto entregue ao Ministério da Saúde em 2025, audiência pública no Congresso, articulação com COFEN e Conselho Nacional de Saúde. Terceiro, o COFEN tem hesitação em normalizar avanços de escopo de prática (parto domiciliar planejado, por exemplo), o que cria um paradoxo: a categoria avança politicamente, mas seu próprio órgão regulador trava parte do movimento.

A leitura estratégica é direta: a Reforma deixou de ser pauta exclusiva de movimentos sociais e ganhou densidade técnico-política. Profissionais plenos da área se posicionarão profissionalmente nos próximos cinco anos — por adesão, por omissão ou por resistência. Este Livebook organiza o quadro analítico para que essa decisão seja informada.

Sobre a Palestrante

Luciane da Silva D'Avila é enfermeira obstétrica e Presidente da ABENFO Nacional. Atuante em Santa Catarina, integra a Comissão de Parto Domiciliar Planejado da ABENFO-SC e representa a categoria em interlocuções com o Ministério da Saúde — recentemente, nas oficinas sobre Implanon, defendendo a prerrogativa de inserção do dispositivo subdérmico por enfermeiras capacitadas.

Como presidente da entidade nacional, está na linha de frente da articulação política da Reforma Obstétrica: liderou a entrega do Manifesto pela Reforma Obstétrica ao Ministério da Saúde em 2025, articulou a audiência pública no Congresso Nacional sobre o tema e coordena a ampliação da formação de novas enfermeiras obstétricas — meta de 750 profissionais em ciclo nacional.

Referências institucionais: abenfo.org.br · abenfosantacatarina.com.br

A Tese Central da Palestra

Reduzida ao núcleo, a tese de Luciane se enuncia em uma única proposição:

A tese

Não haverá mudança substancial nos indicadores de saúde materno-infantil sem mudar quem coordena o cuidado obstétrico. Programas, financiamento e tecnologia são variáveis subordinadas — a variável independente é a arquitetura de autoridade clínica.

Premissas que a tese assume

- **Premissa epidemiológica:** cerca de 85% dos partos são de risco habitual (parâmetro OMS), portanto fisiológicos e tecnicamente passíveis de coordenação por enfermagem obstétrica especializada.
- **Premissa institucional:** políticas brasileiras (PNAISM, Rede Cegonha, Rede Alyne) preservaram a centralidade médico-hospitalar como invariante, ainda que tenham introduzido linguagem de "boas práticas".
- **Premissa comparativa:** países com indicadores melhores (Reino Unido, Nova Zelândia, países nórdicos) operam modelos de midwifery-led care para risco habitual.
- **Premissa de escala:** mesmo aumentos modestos na cobertura por enfermeiras obstétricas com autonomia plena (10% segundo OMS) produzem reduções significativas (23% das mortes maternas e neonatais).

O que a tese provoca

A tese é deliberadamente provocativa: ela retira da pauta debates secundários (mais financiamento, mais leitos, mais protocolos isolados) e os subordina a uma questão de arquitetura. Isso desconforta atores que apostam em soluções incrementais. E desconforta também a parcela da própria enfermagem obstétrica que prefere expandir escopo sem confrontar o status quo médico-corporativo.

O que a tese deixa em aberto

- A redistribuição de autoridade clínica é compatível com a estrutura jurídica brasileira sem alteração legislativa? (Lei do Exercício Profissional, atos privativos)
- A escala de formação atual de enfermeiras obstétricas no Brasil sustenta a transição? (Há gap entre demanda e oferta de profissionais especializadas)
- Como a saúde suplementar — que financia a maior parte das cesarianas eletivas — entra na equação? A Reforma é viável apenas no SUS, ou pressupõe regulação da ANS?
- O modelo proposto sobrevive ao ciclo eleitoral? (PNAISM e Rede Cegonha sofreram reveses em transições governamentais)

Estado da Prática Atual

Antes de avaliar a proposta, vale objetivar o ponto de partida. O modelo brasileiro vigente tem traços estruturais — não conjunturais — que precisam ser enxergados com rigor.

Indicadores que sintetizam o problema

Indicador	Brasil	Referência
Taxa de cesarianas (geral)	~59%	OMS recomenda 10–15%; Brasil é vice-mundial
Cesarianas — saúde suplementar	~85% em alguns hospitais	Maior fator de inflação da taxa nacional
Mortalidade materna	~60/100k nascidos vivos	ODS 2030: 30/100k. Distância significativa
Adequação pré-natal — média geral	15–21%	Apenas 1 em cada 5 mulheres recebe pré-natal recomendado
Adequação pré-natal — mulheres negras	~8%	Indicador-síntese da desigualdade racial estrutural
Gestações não planejadas	~55%	Reflexo da subcobertura em planejamento reprodutivo
Métodos contraceptivos de longa duração	~2%	Subutilização clínica histórica

Indicador	Brasil	Referência
Enfermeiras obstétricas formadas	Estimativa < 5.000 ativas	Para ~2,5 milhões de partos/ano

A arquitetura institucional que produz esses números

Os indicadores não são casuais. Decorrem de uma arquitetura específica que articula quatro dimensões:

1. Modelo assistencial dominante

Hospitalocêntrico, médico-centrado, intervencionista. O parto é tratado como evento clínico de alto risco por padrão — não como processo fisiológico até prova em contrário. Essa premissa inverte o ônus da prova: cada intervenção não precisa ser justificada; é a não-intervenção que precisa.

2. Estrutura de financiamento

No SUS, a tabela de procedimentos historicamente subfinancia o parto vaginal de risco habitual — o que cria incentivo institucional implícito para intervenção. Na saúde suplementar, o pagamento por procedimento e a lógica de agenda médica favorecem a cesariana eletiva. Os incentivos econômicos rodam contra os indicadores desejados.

3. Regulação profissional

A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (Lei 7.498/86) estabelece campo legal para atuação de enfermeiras obstétricas, mas a regulação infralegal (resoluções COFEN) avança de forma desigual. O parto domiciliar planejado, por exemplo, segue sem normativa nacional consolidada — situação que o ABENFO-SC tem buscado destravar regionalmente.

4. Cultura institucional e judicialização

A cultura defensiva da medicina obstétrica brasileira — agravada por percepção de risco jurídico — opera como freio cultural à transição. O profissional obstetra, mesmo aderente conceitualmente ao

parto humanizado, frequentemente "recua para a cesariana" diante da pressão institucional e do receio de processo.

Os gargalos críticos para uma transição

- **Gargalo de formação:** a oferta atual de pós-graduação em Enfermagem Obstétrica é insuficiente para a demanda implícita na proposta da Reforma.
- **Gargalo regulatório:** normativas COFEN inconsistentes entre regiões; ausência de marco federal para parto domiciliar planejado.
- **Gargalo de financiamento:** lógica de pagamento desalinhada com cuidado coordenado por enfermagem obstétrica.
- **Gargalo distributivo:** oferta concentrada em capitais e centros universitários; vazios assistenciais persistentes.
- **Gargalo cultural:** resistência institucional do corpo médico obstétrico tradicional, agravada por percepção de risco jurídico.

A Proposta em Análise Técnica

A Reforma Obstétrica, em sua formulação atual, articula cinco princípios derivados do Modelo de Transição Obstétrica da OMS (2024). Aqui, eles são apresentados não como diretrizes a aplaudir, mas como cláusulas a interrogar.

Os cinco princípios da OMS — leitura crítica

Princípio	O que significa, na prática	Ponto de atenção crítica
Cuidado equitativo baseado em direitos humanos	Decisão clínica respeita o desejo informado da gestante; consentimento e autonomia como pilares	Operacionalização exige tempo de consulta incompatível com a estrutura atual de produtividade
Cuidado centrado na pessoa	Continuidade do vínculo e escuta ativa	Modelo de plantão fragmentado é o oposto disso; transição implica reorganização da escala

Princípio	O que significa, na prática	Ponto de atenção crítica
Assistência baseada em evidências	Práticas validadas, abandono de rotinas obsoletas (episiotomia rotineira, jejum, etc.)	Há descompasso entre evidência e prática institucional ainda presente em residências
Coordenação por enfermeiras obstétricas/obstetrizes	Liderança clínica do cuidado de risco habitual	Núcleo da disputa político-corporativa; exige normativas COFEN e portarias do MS
Cuidado integrado e colaborativo	Equipe multiprofissional com liderança definida	Risco real de "coordenação no papel, hierarquia médica na prática"; desenho de governança importa

Implicações regulatórias

A Reforma só avança com movimentos coordenados em três frentes regulatórias:

- **COFEN:** consolidar resoluções nacionais sobre escopo de prática avançada da enfermagem obstétrica, incluindo parto domiciliar planejado e prescrição de medicamentos para o ciclo gravídico-puerperal.
- **Ministério da Saúde:** atualizar portarias de financiamento de Centros de Parto Normal (CPN) e ampliar a tabela SUS para procedimentos coordenados por enfermagem obstétrica.
- **ANS:** sem regulação da saúde suplementar (que responde por parcela significativa dos partos e pelas taxas mais altas de cesariana), a Reforma fica restrita ao SUS — o que limita seu alcance.

Implicações financeiras

A discussão financeira é sub-tratada em apresentações públicas, mas é definidora. Três pontos merecem destaque:

- **Lógica atual incentiva intervenção:** tabelas de procedimentos remuneram melhor a cesariana e o parto com intervenções do que o parto fisiológico bem conduzido.

- **Cuidado coordenado pede pagamento por episódio:** modelos internacionais bem-sucedidos remuneram a jornada inteira (pré-natal + parto + pós-parto) e não procedimentos avulsos. Isso favorece continuidade.
- **Custo agregado tende a cair:** CPNs e cuidado coordenado por enfermagem obstétrica são, em estudos internacionais, mais custo-efetivos. O argumento financeiro é favorável à Reforma — desde que apresentado com dados.

Implicações de formação

Uma transição estrutural pressupõe escala humana. A Luciane menciona a meta de 750 novas enfermeiras obstétricas em ciclo nacional. Em termos relativos: trata-se de aproximadamente 15–20% de aumento sobre o estoque ativo estimado. É um movimento, mas não é ainda a escala compatível com a demanda da Reforma plena.

Para profissionais plenos: há janela de oportunidade real. Pós-graduação em Enfermagem Obstétrica deve viver demanda crescente nos próximos cinco anos. As principais ofertas hoje (Fiocruz/EPSJV, UNIFESP, UERJ, UFMG, USP-RP) funcionam com fila e seleção. A entrada no campo agora é estrategicamente vantajosa.

Implicações para Sua Prática Profissional

A Reforma Obstétrica não atinge todos os papéis profissionais da mesma forma. Esta seção decompõe implicações por perfil.

Para a enfermeira obstétrica em UBS / atenção primária

- Ampliação efetiva de escopo no pré-natal de risco habitual: condução autônoma, prescrição segundo normativa, alta para casa de parto ou maternidade conforme classificação de risco.
- Integração mais densa com planejamento reprodutivo: indicação e inserção de DIU e implante subdérmico (Implanon) tornam-se prática mais comum, com formação correspondente.
- Liderança em grupos educativos com gestantes e parceiros — agora reconhecida como cuidado, não como atividade complementar.

- Necessidade de protocolos institucionais claros sobre encaminhamento para alto risco, com pactuação formal entre níveis de atenção.

Para a enfermeira obstétrica em maternidade / hospital

- Possibilidade de liderança clínica em CPNs anexos a maternidades, com governança própria e protocolos pactuados de transferência.
- Renegociação ativa de fluxos com corpo médico obstétrico — discussão de quem decide o quê em qual situação, com base em evidências e classificação de risco.
- Documentação clínica robustecida: prontuário com anotações de evolução e decisão clínica passa a ser instrumento de proteção profissional.
- Formação continuada em emergência obstétrica torna-se obrigatória, não opcional — qualquer ampliação de autonomia exige preparo para reconhecer e manejar urgências até a transferência.

Para o obstetra

- Foco crescente em alto risco e complicações — onde a especialização médica gera valor diferencial real.
- Liberação de agenda dos partos de risco habitual abre espaço para acompanhamento mais aprofundado de gestações complexas.
- Necessidade de redesenhar o modelo de remuneração: passar de "volume de partos" para "complexidade de casos manejados".
- Postura colaborativa com enfermagem obstétrica torna-se ativo de carreira — equipes integradas têm desfechos melhores e satisfação profissional maior.

Para o gestor de unidade obstétrica

- Revisão de governança clínica: definição de quem coordena cada classificação de risco, com protocolos escritos e auditoria periódica.
- Redesenho de indicadores: além de taxa de cesariana, monitorar adequação pré-natal por raça, satisfação da gestante, taxa de transferência intra-parto.
- Negociação com a fonte pagadora (gestão SUS ou operadora) sobre modelo de remuneração que sustenta CPN e cuidado por enfermagem obstétrica.

- Política institucional clara sobre judicialização e respaldo jurídico à equipe — sem isso, a transição cultural é instável.

Para o profissional de saúde coletiva / vigilância

- Monitoramento de indicadores estratificados por raça/cor — ponto cego histórico em muitos sistemas territoriais.
- Mapeamento de vazios assistenciais para cuidado por enfermagem obstétrica — insumo direto para planejamento regional.
- Articulação intersetorial com educação (formação) e regulação (COFEN regional) — papel de mediação institucional.

Para o docente / preceptor de campo

- Currículos de graduação em enfermagem precisam expandir carga em obstetrícia (hoje subdimensionada em muitas IES).
- Programas de pós-graduação em Enfermagem Obstétrica vivem demanda crescente — abertura de novas ofertas é oportunidade.
- Preceptoria em CPNs e em domicílio (parto planejado) torna-se campo formativo de alta relevância — competência específica a desenvolver.

Análise de Stakeholders

A Reforma Obstétrica é tecnicamente sustentada e politicamente disputada. Compreender quem está em cada posição e por quê é parte do quadro analítico que um profissional pleno precisa carregar.

Ator	Posição	Motivação central
ABENFO Nacional / regionais	Protagonista	Reconhecimento profissional, ampliação de escopo, formação ampliada

Ator	Posição	Motivação central
COFEN	Apoio formal, ritmo cauteloso	Equilíbrio entre defesa de categoria e prudência regulatória; tem hesitado em normativas avançadas (parto domiciliar)
Movimentos pelo parto humanizado	Apoio histórico	Direitos das mulheres, autonomia corporal, fim da violência obstétrica
Rede Feminista de Saúde / ReUna	Apoio articulado	Pauta interseccional: saúde da mulher negra, justiça reprodutiva
FEBRASGO	Resistência matizada	Defesa do papel do obstetra; preocupação corporativa com perda de mercado
CFM / AMB	Posição corporativa cautelosa	Resistência a redefinição de "atos médicos" e perda de protagonismo
Ministério da Saúde	Mediador	Recebe Manifesto (2025); equilibra interesses; capacidade limitada de coerção
Conselho Nacional de Saúde	Arena política	Espaço de pactuação tripartite; cobertura de movimentos sociais
ANS	Posição fraca	Regulação da saúde suplementar é o "elefante na sala" — cesarianas eletivas são produto rentável
Operadoras de planos de saúde	Resistência implícita	Modelo atual é lucrativo; mudança implica redesenho de incentivos
Universidades / programas de pós	Apoio técnico	Formam profissionais; produzem evidência; capacidade de escala limitada
Gestores municipais SUS	Variável	Depende de prioridade local, alinhamento político e capacidade técnica

Implicações estratégicas dessa configuração

A configuração de forças explica o ritmo da Reforma. Há base técnica, há apoio político, há mobilização social. Mas há também resistência corporativa concentrada em quatro pontos: FEBRASGO, CFM, operadoras de planos e parte do COFEN. A vitória da Reforma não virá de derrotar essas resistências, mas de reconfigurá-las — encontrando arranjos onde obstetras qualificados se

sintam valorizados (alto risco), operadoras enxerguem custo-efetividade (CPNs e parto fisiológico bem conduzido) e o COFEN encontre confiança técnica para avançar normativas.

Modelos Internacionais: Aprendizados Aplicáveis

A leitura comparada de modelos internacionais não pode ser apenas inspiracional — precisa identificar o que se traduz para o contexto brasileiro e o que não.

Reino Unido — NICE Guidelines e Midwifery-led Care

O National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recomenda, com base em revisão sistemática, que mulheres com gestação de risco habitual sejam atendidas em unidades lideradas por midwives (parteiras especializadas). O sistema opera com transferência protocolada para obstetras quando há mudança de classificação de risco. É o modelo mais formalizado do mundo nessa lógica.

- **Aplicável ao Brasil:** arquitetura de classificação de risco e transferência protocolada; protocolos baseados em evidência atualizados ciclicamente.
- **Não traduz diretamente:** integração nacional do NHS é singular; o Brasil opera SUS + saúde suplementar, com governança fragmentada.

Nova Zelândia — Choice of Lead Maternity Carer

Cada gestante escolhe seu Lead Maternity Carer — frequentemente uma midwife, mas pode ser obstetra ou clínico geral. A LMC coordena toda a jornada (pré-natal, parto, puerpério). Modelo de continuidade, com financiamento público para a escolha.

- **Aplicável:** princípio da continuidade do cuidado; vínculo gestante–profissional como variável de qualidade.
- **Não traduz diretamente:** escala populacional reduzida facilita o modelo; aplicabilidade no Brasil exige adaptação regional.

Países Nórdicos (Suécia, Finlândia, Noruega)

Integração total entre atenção primária e secundária. Midwives conduzem cuidado pré-natal e parto; obstetras atuam exclusivamente em alto risco. Indicadores entre os melhores do mundo (cesariana 15–17%, mortalidade materna < 5/100k).

- **Aplicável:** evidência forte de que o modelo funciona em escala; arquitetura institucional que vale estudar.
- **Não traduz diretamente:** estado de bem-estar social, equidade prévia e financiamento universal robusto criam condições estruturais distintas.

Senegal — Cuidado de Base Comunitária

Profissionais de saúde itinerantes garantem cuidado obstétrico, neonatal e contraceptivo em comunidades. Comunidades hospedam profissionais. Adaptação a contextos com baixa densidade institucional.

- **Aplicável ao Brasil:** altamente relevante para Amazônia, semiárido e regiões de difícil acesso. Pode dialogar com a Estratégia Saúde da Família.
- **Não traduz diretamente:** capacidade de mobilização comunitária varia; necessita arranjos locais específicos.

Brasil — Hospital Sofia Feldman (Belo Horizonte)

Caso brasileiro mais consolidado. Modelo de cuidado obstétrico com liderança da enfermagem obstétrica em parto de risco habitual, equipe interdisciplinar integrada, indicadores acima da média nacional. Referência para programas de formação e estágio.

- **Aplicável:** demonstração viva de viabilidade no contexto SUS. Não é experimento — é prática consolidada há décadas.
- **Limites de replicabilidade:** cultura institucional do Sofia Feldman é fruto de construção histórica específica; replicação demanda investimento sistemático em formação e governança.

O que une todos os modelos bem-sucedidos

Padrão comum

Liderança clínica da enfermagem obstétrica em risco habitual + autonomia profissional regulamentada + protocolos de transferência claros + financiamento alinhado + equipe interdisciplinar com governança definida.

Destaques

Cinco passagens que organizam o discurso da palestra, com leitura crítica.

 **"Não haverá mudança substancial na sobrevivência e experiência positiva no parto sem mudança do modelo obstétrico."**

Leitura: tese atribuída à OMS — peso institucional importa. Não é posição corporativa de uma associação, é recomendação técnica do principal organismo internacional de saúde.

 **"Não tem rede cegonha que dê conta, não tem rede alyne que dê conta, se de fato a gente não mexer naquilo que é mais importante."**

Leitura: momento mais contundente. Sintetiza em uma frase a frustração técnica de duas décadas de políticas que não tocaram no eixo estrutural. Para o profissional pleno, é recado direto: não confundir movimento com resultado.

 **"A Rede Cegonha só avançou porque foi abraçada pelas enfermeiras obstétricas e pelas obstetrites."**

Leitura: lição organizacional. Política pública sem apropriação pela ponta vira letra fria. A categoria profissional é variável crítica de implementação — não apenas beneficiária do programa.

 **"Um aumento modesto de 10% pode evitar 23% de mortes maternas e neonatais e 14% de natimortos ao ano."**

Leitura: argumento técnico mais forte da Reforma. A intervenção é proporcionalmente pequena, o efeito é desproporcionalmente grande. Esse é o tipo de evidência que vence resistências em mesa técnica.

 **"Investir no acesso universal ao cuidado obstétrico de qualidade pode, até 2035, salvar 4,3 milhões de vidas todos os anos no mundo."**

Leitura: eleva a discussão para escala global. A Reforma brasileira não é movimento isolado — é parte de um movimento mundial coordenado por OMS, UNFPA e ICM. Posicionar o Brasil nesse contexto é ativo retórico relevante.

Pontos de Atenção e Lacunas

A defesa rigorosa de uma proposta inclui o reconhecimento de seus pontos cegos e dos riscos de implementação. Esta seção organiza o que ainda merece debate técnico.

Riscos de implementação

- **Implementação parcial gera o pior cenário:** enfermeiras obstétricas com autonomia formal mas sem retaguarda de obstetra (em zonas remotas) ou sem protocolo de transferência (em municípios mal estruturados) podem produzir desfechos piores. A transição precisa ser sistêmica.
- **Risco de "midwife-washing":** instituições adotam o discurso, mantêm a prática. Indicadores de auditoria precisam ser claros — taxa de cesariana, episiotomia, transferência intra-parto, satisfação da gestante.
- **Tensão público-privado:** avanços no SUS sem regulação da saúde suplementar produzem assimetria de qualidade. O risco é que o modelo "bom" fique restrito a quem usa SUS e não tenha alternativa.
- **Sobrecarga sobre escassa força de trabalho:** expandir escopo sem expandir formação simultaneamente esgota profissionais já existentes.

Lacunas de evidência (Brasil)

- **Estudos comparativos longitudinais brasileiros:** a maioria das evidências citadas vem de fora do Brasil. Pesquisa nacional comparando modelos em diferentes contextos territoriais é lacuna importante.
- **Análise de custo-efetividade brasileira:** o argumento financeiro precisa de dados nacionais — referências internacionais ajudam, mas convencimento de gestores SUS pede números brasileiros.
- **Desfechos estratificados por raça:** há dados de adequação pré-natal por raça, mas dados de desfecho de parto e pós-parto estratificados ainda são incompletos. Pesquisa estratégica necessária.
- **Dimensão da saúde mental perinatal:** depressão pós-parto, transtornos de ansiedade no ciclo gravídico-puerperal, e como o modelo de cuidado afeta esses desfechos — campo subexplorado.

Debates abertos na agenda

- **Parto domiciliar planejado:** sem normativa federal consolidada, segue como prática regional com regulamentação heterogênea. Posição do COFEN será definidora.
- **Prescrição por enfermeira obstétrica:** escopo de prescrição autônoma para o ciclo gravídico-puerperal precisa de marco regulatório nacional claro.
- **Modelos de pagamento:** transição da lógica de procedimento para episódio de cuidado é discussão técnica complexa, ainda em estágio inicial no Brasil.
- **Articulação com saúde suplementar:** agenda mais sensível e menos avançada. ANS é ator-chave subestimado no debate atual.

Posicionamento Profissional Estratégico

Para o profissional pleno, há decisões a tomar — em alguns casos, agora. Esta seção organiza opções estratégicas que decorrem do quadro analítico anterior.

Decisões de carreira

- **Especialização em Enfermagem Obstétrica:** janela de oportunidade real. Demanda crescente, oferta limitada de programas de qualidade, retorno profissional crescente nos próximos 5 anos.
- **Atualização contínua em evidências:** NICE Guidelines, OMS Modelo de Transição Obstétrica, Lancet Series on Midwifery — são referências centrais. Manter biblioteca ativa.
- **Construção de portfólio profissional:** documentar atuação, casos, indicadores de qualidade, participação em comissões — é ativo crescente em mundo profissional cada vez mais credencialista.

Decisões de prática

- **Documentação clínica robusta:** em cenário de ampliação de autonomia, prontuário bem feito é proteção profissional e instrumento de qualidade.
- **Formação continuada em emergência obstétrica:** autonomia ampliada exige preparo para reconhecer e manejar urgências até a transferência. Não é negociável.
- **Protocolos institucionais por escrito:** em qualquer unidade onde atue, defender a existência de protocolos pactuados de classificação de risco e transferência. Reduz fricção e protege a equipe.

Decisões de engajamento institucional

- **Filiação e engajamento na ABENFO:** a Reforma Obstétrica é articulada por entidade. Profissional que age fora do coletivo perde alavancagem.
- **Participação em comissões locais:** comitês de mortalidade materna, conselhos de saúde, comissões hospitalares — espaços onde política se faz no chão.
- **Diálogo com corpo médico:** evitar postura confrontativa por princípio. A configuração que vence é a colaborativa-com-papéis-definidos. Construir essa relação é parte do trabalho.

- **Comunicação com a sociedade:** profissionais que comunicam bem ganham capital simbólico. Trabalho com mídia, redes sociais e divulgação científica é parte do ativismo profissional contemporâneo.

Disposição para liderança política

A Reforma Obstétrica precisará, nos próximos anos, de profissionais dispostos a ocupar espaços formais — em conselhos, comissões, gestão pública, docência. Profissionais plenos com bom desempenho clínico têm legitimidade técnica para essa migração. A pergunta não é se a categoria precisa de liderança política — precisa. A pergunta é: você está disposto a oferecer parte do seu tempo profissional para isso?

Recursos Estratégicos

Não é trilha pedagógica — é conjunto de ferramentas. Selecionado para profissional pleno que sabe filtrar.

Documentos institucionais centrais

- Manifesto pela Reforma Obstétrica (ABENFO + Rede Feminista de Saúde + ReUna + entidades aliadas, 2025) — referência de articulação política.
- Modelo de Transição Obstétrica — Organização Mundial da Saúde, 2024. Documento técnico de referência mundial.
- Lancet Series on Midwifery (2014, com atualizações) — base de evidência seminal sobre impacto global da liderança da enfermagem obstétrica.
- NICE Guideline NG194: Antenatal care e CG190: Intrapartum care — protocolos do Reino Unido frequentemente citados como referência.
- Pesquisa "Nascer no Brasil" (Fiocruz, 2014 e desdobramentos) — base estatística nacional fundamental.

Periódicos relevantes

- Cadernos de Saúde Pública (Fiocruz)
- Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn)

- Revista Latino-Americana de Enfermagem (Ribeirão Preto)
- BMC Pregnancy and Childbirth
- Birth: Issues in Perinatal Care
- Midwifery (Elsevier)

Eventos profissionais

- SIAPARTO — Cia Parto
- Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal — ABENFO Nacional
- Congresso ICM (International Confederation of Midwives) — bienal
- Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva — ABRASCO
- Reunião Mundial de Saúde Materno-Infantil — OMS / UNFPA

Programas de pós-graduação em Enfermagem Obstétrica (Brasil — referências consolidadas)

- Fiocruz / EPSJV — Rio de Janeiro
- UNIFESP — São Paulo
- UERJ — Rio de Janeiro
- UFMG — Belo Horizonte
- USP-RP — Ribeirão Preto
- UFSC — Florianópolis

Redes profissionais e de mobilização

- ABENFO Nacional e seccionais estaduais
- Rede Feminista de Saúde
- Brasco — Brasil pela Saúde da Mulher
- ReUna — Rede pela Universalização da Atenção Obstétrica
- Rede de Doulas (regionais)
- International Confederation of Midwives (ICM)

Plataformas de educação continuada

- TelessaúdeRS-UFRGS — material gratuito de alta qualidade
- NUTES-UFPE — cursos abertos em saúde materno-infantil
- Plataforma Avasus (Ministério da Saúde) — cursos pontuais
- Plataformas internacionais: Coursera (cursos da Universidade de Edimburgo, Johns Hopkins), FutureLearn (UK)